

19 - 11- LE PLACENTA PREAVIA - Pr. BASSIR

Bonjour, aujourd'hui on va voir un cours de placenta previa. Donc le placenta previa c'est parmi les causes des métroragies du deuxième, troisième trimestre. Et comme introduction, c'est un placenta qui est inséré sur toute ou une partie du segment inférieur.

A partir du troisième trimestre, c'est-à-dire à la fin du 28e semaine d'améliorer. Deux risques du placenta previa. Le premier risque c'est le risque hémorragique qui engage le pronostic maternel.

Et le deuxième risque qui engage le pronostic foetal, c'est l'accouchement prématuré. L'épidémiologie. L'incidence c'est 1 cas sur 200 accouchements.

0 à 30% des métroragies du troisième trimestre. La fréquence réelle est difficile à établir. C'est à peu près 0,3 à 2,66%.

Pourquoi? Parce que pour avoir une fréquence juste, il faut avoir des critères cliniques qui sont adaptés. Parfois on a des formes hémorragiques, mais parfois il y a des formes asymptomatiques. Chez qui le diagnostic n'a pas été établi.

La méthode de diagnostic qui est l'échographie. Donc ça dépend du clinicien qui a fait l'échographie. Le moment du diagnostic également au cours de la grossesse.

Si on fait une échographie au cours du deuxième trimestre, par exemple vers 20 semaines, on peut avoir un placenta bas inséré, mais ce placenta peut monter au cours de la grossesse pour devenir fendique. Et selon les variétés anatomiques retenues, est-ce qu'il est bas inséré ou bien est-ce qu'il est retenu? Pour les étiologies, les étiologies réelles sont inconnues. Certains facteurs sont favorisants qui sont individualisés.

Il y a l'âge maternel avancé. La fréquence augmente avec l'âge. Dans plus de 35 ans, le risque est de 2 à 4,5.

La multiparité également augmente le risque. Les antécédents d'avortement et de courtage. Les cicatrices utérines et les lésions endométriales, à savoir antécédents de césarien, d'une myomectomie, d'une cure de signi-chi ou bien des manœuvres endo-utérines.

Et les antécédents de placenta prévia. Les grossesses multiples également c'est un facteur de risque. Il y a d'autres facteurs qui sont incriminés, à savoir les malformations utérines, les fibromes sous muqueux, la dénomiose et la consommation de drogues comme la nicotine et la cocaïne.

La race, la race noire est plus à risque. Et les conditions socio-économiques dont le rôle n'est pas évident. Pour la classification anatomopathologique du placenta.

Donc le schéma, la première image à gauche qui montre un placenta qui est normal. Donc c'est

un placenta qui est inséré au niveau du fond utérin. B, l'image B, c'est un placenta qui n'est pas inséré, ça veut dire que le bout du placenta arrive au contact du segment inférieur sans le couvrir.

C, c'est un placenta prévia partiel, ça veut dire que le placenta couvre pas la totalité du segment inférieur mais à peu près la moitié du segment inférieur. Et la dernière image à droite, c'est un placenta totalement recouvrant. C'est le placenta qui s'insère sur la totalité du segment inférieur.

Pour la pathogénie, deux mécanismes peuvent être évoqués. Soit ce placenta, il devient bas inséré ou recouvrant parce que l'annidation primitive du blastocyste, il se fait initialement sur le segment inférieur. Soit c'est une implantation qui est secondaire, c'est l'extension progressive vers l'orifice cervical.

D'ailleurs c'est la théorie qui est plus évoquée chez les patientes multiparts ou bien les grossesses multiples. Pour le diagnostic, le diagnostic clinique, les signes généraux, ils sont en fonction du degré de l'hémorragie. Ils peuvent aller d'un état hémodynamique stable, une patiente qui est stable, qui vient pour un saignement, ou bien qui vient en état de choc suite à une hémorragie très importante.

Les signes fonctionnels sont des métrorragies, qui sont rougeâtres, abondantes, sans douleur, qui ne sont pas douloureuses. Ça veut dire que la patiente ne présente pas, ne sent pas des contractions utérines, sauf exceptionnellement, dans certains cas exceptionnels. Les signes physiques, donc bien sûr, il faut voir la vitalité, la viabilité de ce fœtus.

Généralement les BCF, ils sont positifs, à l'inverse ou bien au contraire que l'hématome, du contraire de l'hématome rétro-placentaire. L'utérus, c'est un utérus qui est souple, pas de contractions, rarement qu'on trouve des contractions. Et une chose qui est très importante, métrorragie troisième trimestre, contre-indique le toucher vaginal, pas de toucher vaginal.

Pour le diagnostic paraclinique, donc métrorragie, ça veut dire réaliser une échographie obstétricale, pour éliminer un placenta prévia, comme j'ai dit, qui est contre-indique le toucher vaginal. Cette échographie doit être réalisée à vessie pleine, donc il permet de préciser la vitalité du fœtus, la présentation, ce qu'est l'encéphalique ou siège ou autre, la biométrie du fœtus, la maturité des signes de maturité fœtale, et il permet d'étudier le placenta. D'abord le siège de ce placenta, est-ce qu'il est fin-indiqué ou est-ce qu'il est bas-inséré, est-ce qu'il est antérieur ou postérieur qui change la classification.

Donc une fois qu'on réalise cette échographie obstétricale, donc on permet de préciser l'étude du placenta, on peut réaliser une échographie endovaginale. Cette échographie endovaginale, le rôle c'est de préciser le type, et la classification la plus utilisée dans le placenta prévia, c'est la classification 2b6, qui diffère en fonction du siège de placenta, antérieur ou postérieur. Si le placenta est antérieur, le type 1, c'est quand le placenta arrive au tiers supérieur de la vessie, le type 2, le placenta arrive au deux tiers supérieur de la vessie, le type 3, il atteint le col, et le type

4, il dépasse le col, arrivant à la paroi postérieure.

Sur ce schéma, ça permet de préciser les types du placenta, donc type 1, c'est le tiers supérieur de la vessie, 2, c'est les deux tiers, 3, c'est l'arrivée au niveau du col, et 4, c'est le type recouvrant. Paraclinique, il faut réaliser toujours un enregistrement du rythme cardiaque fœtal, qui permet de détecter une souffrance fœtale aiguë. Pour les formes cliniques, selon les symptômes, on peut avoir des formes asymptomatiques, donc un placenta prévient sans aucun signe, sans saignement, sans rien, et la découverte se fait lors de la réalisation des échographies.

Comme on peut avoir des hémorragies cataclysmiques qui nécessitent la réalisation d'une césarienne en urgence afin de faire le sauvetage maternel. Également, il y a les formes selon le moment du diagnostic, et là, comme forme clinique, c'est l'insertion basse du placenta pendant les deux premiers trimestres de la gestation. Selon la variété topographique, un placenta prévient central, qui couvre la totalité du col, un placenta prévient marginal antérieur, le risque est surtout au moment de la césarienne, parce que lorsqu'on ouvre, on fait l'incision au niveau du segment inférieur, donc la première chose qu'on tente, c'est sur le placenta, et donc il nécessite une extraction d'urgence avec une délivrance artificielle rapide pour éviter le saignement.

Un placenta prévient marginal antérieur, et là, le risque, c'est que ce placenta, il fait pousser la tête en avant, il l'empêche de s'engager, c'est un placenta avec une tendance hémorragique augmentée et un risque de compression du cordon qui est plus fréquente. Pour les formes cliniques compliquées, le placenta prévient, il peut être compliqué d'une procédance du cordon, quatre fois et les plus fréquentes, les formes associées à un décollement prématuré du placenta, un hématome rétro-placentaire, et là, il aggrave le pronostic fœtal et maternel, les formes qui sont compliquées de troubles de la coagulation, et une forme qui devient de plus en plus fréquente, c'est le placenta acréta, et il est secondaire par la fréquence des curtages, la fréquence des césariennes, et bien sûr, chez les multipares, plus. Ce placenta prévient, on l'a défini comme une adhérence anormale du placenta au myomètre, due à l'absence focalisée au diffuse de la caduque basale qui s'interpose entre les villosités et le myomètre utérin.

Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite, ce placenta, il commence à creuser dans la paroi utérine, au niveau du segment inférieur, et il ne se limite pas au niveau du myomètre, il peut le dépasser, il peut aller au niveau de la vessie, au niveau du rectum, en arrière. Ce placenta acréta, si on ne fait pas le diagnostic correct au cours de la grossesse, on peut avoir des hémorragies massives au moment de la délivrance, et le traitement, il peut aller jusqu'à l'hystérectomie des moustaches. Pour le diagnostic différentiel, avec la rupture utérine, dans la rupture utérine, on a des douleurs brutales, un état de choc avec malaise, et les BCF sont souvent négatifs avec l'aspect de fœtus sous la peau.

Le diagnostic différentiel autre, c'est l'hématome décidual basale, la CHRP. Là, on a des douleurs qui sont brutales, un coup de poignard, intense, persistante, un état d'hypertonie continu, les métrorragies, ils sont minimes, ils sont noirâtres et incoagulables, et le plus souvent,

c'est dans un contexte de prééclampsie. L'hématome décidual marginale, c'est un hématome entre la paroi utérine et la caduque basale, en contact de l'insertion des membranes sur le placenta.

Et, suite à la rupture d'un sinus marginal, on aura une hémorragie massive. La rupture d'un vaisseau ombilical, c'est ce qu'on appelle l'hémorragie de Benkiser. Au cours d'une insertion, c'est une insertion vélamonteuse du cordon qui donne une hémorragie brutale, foudroyante, avec état de souffrance fœtale lors de la rupture de la poche des os.

Et le diagnostic, il se pose, généralement, la patiente est acheminée directement au bloc, suite à cette hémorragie importante et l'état de souffrance fœtale, et on fait le diagnostic après la délivrance par l'examen du placenta. Et les diagnostics différentiels. Autres sont les hémorragies génitales, donc cancer du col ou bien une polype.

La conduite à tenir, c'est l'hospitalisation et de règles. Donc, elle est obligatoire dans un centre spécialisé multidisciplinaire qui assure la présence du pédiatre et du réanimateur. Et elle est la conduite à tenir aux tricales et en fonction de trois facteurs.

L'importance du saignement, la localisation du placenta et la gestationnelle. Avant-terme, il faut hospitaliser la patiente et cette hospitalisation peut durer jusqu'à l'accouchement, surtout dans les formes hémorragiques. Le repos avec une surveillance, surveillance clinique de l'état hémodynamique, évaluation du saignement, une surveillance obstétrique de la hauteur utérine des BCF, de la tonicité utérine.

Il faut prévoir deux voies veineuses, une à deux voies veineuses périphériques en fonction du degré de saignement. Réaliser un bilan biologique, NFS, plaquettes, hématocrite, groupage avec la demande de sang qu'il ne faut pas oublier. Il faut faire un remplissage visuel et échographique pour réaliser une échographie pour préciser le type du placenta.

Compenser les pertes sanguines en fonction de l'hémoglobine, traitement martial ou bien transfusion. La tocolyse, si la patiente est contractée, une courte psychothérapie, donc si le saignement survient avant 34 semaines d'aménorrhée et si on prévoit une extraction avant terme. Il ne faut pas oublier de faire une prévention à l'hormonisation si la patiente est résus négatif.

Si le placenta prévia hémorragique avait état de choc non jugulé, à ce moment-là, il faut extraire ce bébé par césarienne pour sauver la maman. Le retour à domicile est permis s'il n'y a pas de récurrence hémorragique, si la patiente n'habite pas très loin de l'hôpital. Si le placenta prévia est de type 1 ou 2, loin du terme, et bien sûr avec une bonne information des parents sur le repos au lit, il ne faut pas qu'ils fassent d'efforts au biais d'un rapport sexuel.

L'accouchement par voie basse est permis si le placenta prévia n'est pas recouvrant et si la présentation est céphalique, bien sûr, en dehors des autres contre-indications obstétricales.

L'accouchement par césarienne programmé, si le placenta prévia est recouvrant, s'il est marginal postérieur, si on a une présentation vicieuse ou bien s'il y a une indication obstétrique, à savoir par exemple une macrosomie ou autre chose. A terme, la conduite à tenir consiste à mettre en condition la partie ruante avec des mesures de rayures en fonction du retentissement du saignement.

Césarienne en urgence, comme on a dit, si le placenta est totalement recouvrant, hémorragique, une présentation vicieuse, une dysthocie ou bien une souffrance fœtale. La voie basse est permis si le placenta est latéral, qui n'est pas hémorragique et si la présentation est céphalique. Il faut réaliser la rupture artificielle des membranes sous monitoring permanent.

Et bien sûr, une surveillance maternelle fœtale et du déroulement du travail et de règles. Au moment de la délivrance, il faut faire l'examen du délivré pour poser le diagnostic. Si le diagnostic n'a pas été posé à l'avance, et pour confirmer notre diagnostic, c'est le petit côté des membranes qui est inférieur à 10 cm.

Il faut prévenir l'hémorragie de la délivrance par une délivrance dérigée. Et si l'hémorragie survient avant la délivrance, là il faut faire une délivrance artificielle avec révision utérine. Bien sûr, on suspecte là le placenta acréta.

Et si effectivement on a fait la délivrance artificielle avec la révision et qu'on n'arrive pas à enlever la totalité du placenta, on peut suspecter le placenta acréta qui nécessite la réalisation d'une laparotomie en urgence. Dans les suites de couches, il faut corriger l'animé, il faut prévenir l'iso-immunisation si la patiente est résiste négative, une antibiothérapie est indispensable, lever précoce avec inscription de l'héparine de bas poids moléculaire et la surveillance de l'état hémodynamique. Le pronostic, comme on a dit au début, est langage le pronostic maternel et le pronostic foetal.

Pour le pronostic maternel, la mortalité, généralement, elle est quasi nulle. Généralement, une patiente qui commence à saigner, il va directement aux urgences obstétricales, au premier centre. Le sauvetage, il se fait le plus souvent, très rapidement.

De ce fait, la mortalité, généralement, elle est presque nulle. Mais la morbidité maternelle, elle est importante. Il y a le risque d'anémie avec, bien sûr, tout ce qui est risque de transfusion sanguine, tout ça.

Il y a risque d'infection fréquente, d'endométrite et le risque de complications thrombo-emboliques. Le pronostic néonatal, la mortalité périnatale est en fonction de l'âge gestationnel et, généralement, la prématurité induite. C'est la première cause de décès.

Le poids foetal, également, il est en fonction des hémorragies maternelles importantes. S'il est important, donc, il y a risque de souffrance foetale. Déjà, c'est un bébé, c'est un nouveau-né qui est souffrant et, donc, il risque d'être hospitalisé dans une unité de soins intensifs avec, bien sûr,

tous les risques, surtout s'il est prématuré, s'il a un petit poids.

En fonction de la variété anatomique du placenta, du mode d'accouchement par césarien ou par voie basse, du traitement conservateur ou bien de l'extraction immédiate, si on va attendre ou bien si on va l'extraire en urgence et, bien sûr, en fonction des conditions de la césarienne. La morbidité neonatale, ça dépend des accouchements prématurés, de ses complications, la rupture prématurée des membranes, le retard de croissance intra-utérin, les anomalies de la présentation, les basseaux prévia et les malformations congénitales. En conclusion, c'est 20% des hémorragies du troisième trimestre.

Souvent, si on cherche, on trouve toujours des facteurs de risque. L'échographie, c'est la clé du diagnostic. Jamais de toucher vaginal.

Le diagnostic, il se pose devant un saignement rougeâtre et son douleur. Il faut savoir qu'on a une morbidité, une mortalité maternelle-fatale plus ou moins importante et ce placenta prévia augmente le taux de césarienne au cours de la grossesse. Je vous remercie.